

03/08 8:30h

INDICADO POR: *Dra Priscila*

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

IDADE: 62	PESO: 70	ALTURA: 163	PROFISSÃO: <i>Aposentado - Engenheiro</i>
SINTOMAS: <i>Sonolência diurna / leve edema mm.II / Acorda c/ boca seca</i>			
QUEIXAS: <i>Relata estar mais lento / acorda c/ próprio ronco.</i>			
MEDICAMENTOS: <i>Ara 3 (125 mg)</i>			
<i>HAS</i>			
MÉDICO: <i>Posição dormir DLD</i>			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>Pilates (2x semana)</i>			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: <i>S</i> ALMOÇO: <i>S</i> LANCHE: <i>—</i> JANTAR: <i>S</i>			
HORA QUE DORME: <i>23</i> HORA QUE ACORDA: <i>0h</i>			
COCHILHO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE			
TEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: ☒ S () N			
BEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N <i>(vinho à noite) gata faz barulho</i>			
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>nasal</i> BANHEIRO/NOITE: <i>2 a 3x</i>			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:			
OVERLAP: <i>não</i> MALLAMPATI: IAH: SPO2:			
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>3 pins ombro (E) / Ruptura tendão ombro (D). Retirado da vesícula /</i>			
CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:			
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: <i>—</i> PRESSÃO NO EXAME: <i>—</i>			
<i>25/07 Avaliação Anon.</i>			
<i>25</i>			

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: CARLOS ALBERTO SATIO KAYANO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 24-10-2024

Idade: 62 anos

Peso: 70 kg

Altura: 1,63 m

Médico Solicitante: DRA. PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 24/10/2024 21:01 e finalizado às 25/10/2024 05:45.

A latência para início do sono foi de 10,0 min e a latência para o sono REM de 115,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 417,5 min, com eficiência do sono de 79,8 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 4,1 % de estágio N1, 56,0 % de estágio N2, 14,5 % de estágio N3 e 25,4 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 95,5 min. Ocorreram 129 despertares, sendo o índice de 14,8 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 184, sendo 23 apneias obstrutivas, 1 apneia central, 0 apneias mistas, 160 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 26,4 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 42,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 21,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 26,4 (nº/h), sendo 3,4 apneia/h e 23,0 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 96%, a média de 95% e a mínima de 82%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 13,4 (nº/h), sendo que em REM foi de 31,7 (nº/h) e em NREM foi de 11,7 (nº/h). Permaneceu 0,7 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.